Antiépileptiques : le référentiel

Classes, spécialités, doses usuelles et maximales, dosages, surdosage, conditions de prescription.
EHPAD · FAM · EAM · MAS · IME — médecins DOTR, médecins coordonnateurs

FICHE PRATIQUE DOTR
MÉDICAMENTS & SÉCURITÉ
Mise à jour : Octobre 2026

À RETENIR

Monothérapie d'abord. Dosage sanguin non systématique, seulement sur point d'appel clinique (inefficacité, toxicité, observance, interactions, grossesse). Valproate, topiramate, carbamazépine : attestation d'information annuelle chez la femme en âge de procréer ; valproate : aussi chez l'homme.

Sources : HAS, Épilepsies : prise en charge des enfants et des adultes, octobre 2020 · ANSM, valproate, carbamazépine, topiramate (13/12/2024, MAJ 27/03/2025 ; 06/11/2025) ; prégabaline (2021)

1 · Quelle molécule pour quelle épilepsie ? (HAS 2020)

Situation	Recommandation
Principe	Monothérapie en première ligne (R46).
Épilepsie focale	Les données ne permettent pas de prioriser une molécule (R68).
Généralisée idiopathique, myoclonique juvénile	Lamotrigine ou lévétiracétam quel que soit le sexe ; valproate chez le garçon ; chez la fille, valproate seulement après échec (R73).
Absences de l'enfant	Éthosuximide en première intention (R69, grade B). Adolescent : lamotrigine, ou valproate chez le garçon (R74).
Femme en âge de procréer	Valproate contre-indiqué en première intention (R66, grade B) ; dose minimale efficace avant la conception ; acide folique 5 mg/j au moins 4 semaines avant la conception et jusqu'à 12 SA (R170, R174).
Sujet âgé	Évaluation cognitive avant traitement hautement souhaitable (R188) ; facteurs de risque vasculaire : privilégier un antiépileptique non inducteur enzymatique (R152).
Dosages sanguins	Non systématiques : uniquement sur point d'appel clinique (R112) ; en préconceptionnel au cas par cas (R173).

Sources : HAS, Épilepsies : prise en charge des enfants et des adultes, octobre 2020

CONDITIONS DE PRESCRIPTION À CONNAÎTRE

- **Valproate** : femme et fille, prescription initiale **annuelle** par neurologue ou pédiatre (psychiatre si bipolaire) ; homme, initiale par neurologue, psychiatre ou pédiatre ; **attestation annuelle** ; renouvellement par tout médecin.
- **Topiramate** : femme et fille, initiale annuelle par neurologue ou pédiatre (médecin « douleur » en migraine), attestation annuelle.
- **Carbamazépine** : femme et fille, attestation annuelle (depuis le 06/01/2025).
- **Prégabaline** : ordonnance sécurisée, 6 mois maximum. **Clonazépam** : sécurisée, 12 semaines, initiale annuelle par neurologue ou pédiatre. **Clobazam** : 12 semaines.
- **Felbamate, vigabatrin, rufinamide, stiripentol, cannabidiol, fenfluramine** : prescription spécialisée et surveillance obligatoire.

Sources : BDPM, spécialités commercialisées et conditions de prescription, 14/10/2026 · ANSM, valproate, carbamazépine, topiramate (13/12/2024, MAJ 27/03/2025 ; 06/11/2025) ; prégabaline (2021)

INDUCTEURS ENZYMATIQUES

Carbamazépine, phénytoïne, phénobarbital, primidone.

- Contraception hormonale **inefficace** : DIU ou méthode barrière (HAS R156).
- Nombreuses interactions : anticoagulants oraux directs, opioïdes, antipsychotiques, antidépresseurs…
- Sujet âgé à risque vasculaire : **préférer un non-inducteur** (HAS R152).

Oxcarbazépine, eslicarbazépine, topiramate, pérampanel, rufinamide, cénobamate peuvent aussi diminuer l'efficacité des contraceptifs oraux.

Sources : HAS, Épilepsies : prise en charge des enfants et des adultes, octobre 2020 · RCP des spécialités : base de données publique des médicaments (ANSM, 15/10/2026) ou EMA

2 · Molécule par molécule (adulte)

Canaux sodiques

Molécule · spécialités	Crises	Dose usuelle	Dose max	Zone mg/L	Surdosage
Carbamazépine · Tegretol, Tegretol LP + génériques	Focales · Tonico-cloniques	400–1 200 mg/j	1 600–2 000 mg/j (certains cas)	4 – 12 (+ époxyde ≤ 2,3)	coma, convulsions, QRS large / QT long, hyponatrémie ; hémodialyse
Oxcarbazépine · Trileptal + génériques	Focales	600–2 400 mg/j	2 400 mg/j (plus haute dose étudiée)	3 – 35 (MHD)	hyponatrémie, somnolence, ataxie, QT long
Eslicarbazépine · Zebinix + génériques	Focales	800–1 200 mg × 1/j	1 200 mg/j (1 600 en monothérapie)	3 – 35	convulsions, arythmies ; hémodialyse
Phénytoïne · Di-Hydan, Dilantin	Focales · Tonico-cloniques	2–6 mg/kg/j (≈ 300 mg/j)	500–600 mg/j	10 – 20 (libre : fraction ≈ 10 %)	nystagmus, ataxie, dysarthrie, coma ; cinétique saturable
Fosphénytoïne (IV) · Prodilantin	État de mal · Post-neurochirurgie / TC	charge 15 mg EP/kg ; 4–5 mg EP/kg/j	débit ≤ 150 mg EP/min	phénytoïne 10 – 20	hypotension, troubles de conduction, asystolie
Lamotrigine · Lamictal + génériques	Focales · Tonico-cloniques · Absences · Lennox-Gastaut	100–200 mg/j (200–400 avec inducteurs)	non libellée (500–700 mg/j chez certains)	2,5 – 15	coma, convulsions, QRS large / QT long
Lacosamide · Vimpat + génériques	Focales · Tonico-cloniques (EGI)	200–400 mg/j	400 mg/j (600 en monothérapie)	10 – 20	convulsions, troubles de conduction, coma
Rufinamide · Inovelon	Lennox-Gastaut	selon le poids	1 800–3 200 mg/j selon le poids	30 – 40 (Lennox-Gastaut)	pas de signe majeur rapporté

Mécanismes multiples

Molécule · spécialités	Crises	Dose usuelle	Dose max	Zone mg/L	Surdosage
Valproate de sodium · Depakine, Depakine Chrono, Depakote, Depamide, Divalcote, Micropakine LP + génériques	Focales · Tonico-cloniques · Absences · Myoclonies · Lennox-Gastaut	20–30 mg/kg/j	non précisée (RCP)	50 – 100	coma calme, myosis, dépression respiratoire, acidose ; hyperammoniémie : carnitine
Topiramate · Epitomax + génériques	Focales · Tonico-cloniques · Lennox-Gastaut	100–200 mg/j (200–400 en association)	500 mg/j (monothérapie)	5 – 20	somnolence, troubles visuels, acidose métabolique ; hémodialyse
Zonisamide · Zonegran + génériques	Focales	300–500 mg/j	500 mg/j	10 – 40	coma, bradycardie, dépression respiratoire
Felbamate · Taloxa	Lennox-Gastaut	titration jusqu'à l'effet	3 600 mg/j	30 – 60	ataxie, nystagmus, cristallurie, coma
Cénobamate · Ontozry	Focales (après 2 échecs)	200 mg/j	400 mg/j	non établie	somnolence, fatigue, vertiges

Protéine SV2A

Molécule · spécialités	Crises	Dose usuelle	Dose max	Zone mg/L	Surdosage
Lévétiracétam · Keppra, Levidcen + génériques	Focales · Myoclonies (EMJ) · Tonico-cloniques (EGI)	1 000–3 000 mg/j	3 000 mg/j	12 – 46	somnolence, agressivité, coma ; hémodialyse
Brivaracétam · Briviact + génériques	Focales	100 mg/j (50–200)	200 mg/j	0,2 – 2	somnolence, vertiges

Antiépileptiques : le référentiel

Voie GABA

Molécule · spécialités	Crises	Dose usuelle	Dose max	Zone mg/L	Surdosage
Phénobarbital · Gardenal + génériques	Focales · Tonico-cloniques	2–3 mg/kg/j	non précisée (RCP)	10 – 40	coma, bradypnée, hypotension ; diurèse alcaline
Primidone · Mysoline	Focales · Tonico-cloniques	750–1 500 mg/j	1,5 g/j	5 – 10 (doser aussi le phénobarbital)	dépression du SNC, coma ; cristallurie
Vigabatrin · Kigabeq, Sabril	Focales résistantes · West	2–3 g/j	3 g/j	0,8 – 36 (non corrélé à l'effet)	somnolence, coma, psychose
Tiagabine · Gabitril	Focales	30–50 mg/j (avec inducteurs)	non précisée (RCP)	0,02 – 0,2	convulsions, état de mal, coma
Stiripentol · Diacomit	Dravet	50 mg/kg/j	non précisée (RCP)	8 – 12 (Dravet)	aucune donnée
Clobazam · Likozam, Urbanyl	Toutes crises, en association	20–30 mg/j	60 mg/j	0,03 – 0,3 (+ N-desméthyl 0,3 – 3)	dépression du SNC ; flumazénil (risque convulsif)
Clonazépam · Rivotril	Focales · Généralisées (toutes) · Lennox-Gastaut · West	0,05–0,1 mg/kg/j	non chiffrée (RCP)	0,02 – 0,07	dépression du SNC, aggravation des crises

Ligands alpha-2-delta (gabapentinoïdes)

Molécule · spécialités	Crises	Dose usuelle	Dose max	Zone mg/L	Surdosage
Gabapentine · Neurontin + génériques	Focales	900–3 600 mg/j	3 600 mg/j	2 – 20	somnolence, diplopie, dysarthrie
Prégabaline · Lyrica + génériques	Focales	150–600 mg/j	600 mg/j	2 – 8	somnolence, confusion, convulsions

Spécifique des absences

Molécule · spécialités	Crises	Dose usuelle	Dose max	Zone mg/L	Surdosage
Éthosuximide · Zarontin	Absences · Myoclonies · Atoniques	20 mg/kg/j (≈ 1,5 g/j)	2 g/j	40 – 100	somnolence, nausées, incoordination

Récepteurs AMPA (glutamate)

Molécule · spécialités	Crises	Dose usuelle	Dose max	Zone mg/L	Surdosage
Pérampanel · Fycompa	Focales · Tonico-cloniques (EGI)	4–8 mg/j	12 mg/j	0,18 – 0,98	agressivité, coma (demi-vie longue)

Encéphalopathies rares

Molécule · spécialités	Crises	Dose usuelle	Dose max	Zone mg/L	Surdosage
Cannabidiol · Epidyolex	Lennox-Gastaut · Dravet · Sclérose tubéreuse	10 mg/kg/j	20 mg/kg/j (25 : sclérose tubéreuse)	non établie	diarrhée, somnolence
Fenfluramine · Fintepla	Dravet · Lennox-Gastaut	0,7 mg/kg/j	26 mg/j (17 avec stiripentol)	non établie	agitation, confusion, tremblements, fièvre, mydriase

Zone mg/L : concentration résiduelle de référence à l'équilibre (Patsalos 2018), à interpréter avec la clinique. Doses : RCP de la spécialité de référence ; adapter au sujet âgé, au rein et au foie (version interactive). Sources : RCP des spécialités : base de données publique des médicaments (ANSM, 15/10/2026) ou EMA ; BDPM, spécialités commercialisées et conditions de prescription, 14/10/2026 ; HAS, Épilepsies : prise en charge des enfants et des adultes, octobre 2020 ; ANSM, valproate, carbamazépine, topiramate (13/12/2024, MAJ 27/03/2025 ; 06/11/2025) ; prégabaline (2021) ; Patsalos PN et al., Therapeutic drug monitoring of antiepileptic drugs : a 2018 update, Ther Drug Monit 2018;40:526-548.

Fiche pratique DOTR, octobre 2026. Données des RCP (ANSM / EMA) et de la base publique des médicaments ; ne remplace ni le RCP ni l'avis du neurologue. Version interactive détaillée sur l'Espace VMS / DOTR.

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.